

日本人 COVID-19 入院患者における 医療ケア後の重症化リスク因子に関する 後ろ向きコホート研究

研究計画書

研究代表者

研究メンバー（マスク済み）
所属機関名（マスク済み）・職位（マスク済み）
〒 000-0000 住所（マスク済み）
TEL: 000-000-0000 FAX: 000-000-0000
E-mail: masked@example.com

研究事務局

研究メンバー（マスク済み）
所属機関名（マスク済み）・職位（マスク済み）
〒 000-0000 住所（マスク済み）
TEL: 000-000-0000 FAX: 000-000-0000
E-mail: masked@example.com

第 1.0 版
令和 8 年 1 月 2 日

研究計画書の改訂記録

版数	作成 (改訂) 年月日
第 1.0 版	令和 8 年 1 月 2 日

機密情報に関する注意

本研究計画書は、機密情報であり、本研究に参加する医療機関、研究責任者、研究分担者、研究協力者、倫理審査委員会等の臨床研究関係者に対して提供されるものです。

本研究計画書は、研究対象者に対して本研究の内容を説明する場合を除き、研究責任者の文書による同意なしに、いかなる第三者にも開示または本研究の目的以外に利用することはできません。

目次

研究計画書の改訂記録	1
1 研究の名称	4
2 研究の背景	4
3 研究の目的および意義	4
4 研究対象者の選定方針	5
5 研究の方法および研究の科学的合理性の根拠	6
6 方法	6
7 観察・検査・調査・報告項目とスケジュール	7
8 解析の概要	8
9 研究期間	9
10 インフォームド・コンセント (IC) を受ける手順	10
11 個人情報等の取り扱い	11
12 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスクおよび利益・総合的評価・対策	12
13 試料・情報の保管および廃棄の方法	13
14 試料・情報の二次利用および他研究機関への提供の可能性	13
15 倫理審査委員会及び研究機関の長への報告内容および方法	14
16 研究の資金・利益相反	14
17 研究対象者等およびその関係者からの相談等への対応	15
18 研究対象者等の経済的負担または謝礼	15
19 研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む）等の取扱い	15
20 研究の実施体制	16
21 研究実施計画書の変更、および改訂	17

22 遵守すべき倫理指針、倫理審査	18
23 研究成果の帰属	18
24 参考文献	18

1 研究の名称

日本人 COVID-19 入院患者における医療ケア後の重症化リスク因子に関する後ろ向きコホート研究

2 研究の背景

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (SARS-CoV-2) によって引き起こされる感染症である。パンデミックの初期、特に武漢株およびその後のアルファ変異株、デルタ変異株が優勢であった時期には、世界的に死亡率が高かった。日本における死亡率は世界的に見ても低い水準にあると報告されているが、ワクチンが利用できなかった武漢株流行期においても、一部の患者群では共通の因子や併存疾患に関連した病態の悪化が見られた。

これまでの複数国からの研究により、COVID-19 の予後に影響を与える様々な因子が同定されている。報告されているリスク因子には、年齢、性別、併存疾患の数と種類、呼吸数、体格指数 (BMI)、末梢酸素飽和度、グラスゴー昏睡尺度 (GCS) などで測定される意識レベルが含まれる [1, 2]。予後指標として報告されている検査パラメータには、白血球数、リンパ球数、血糖、アルブミン、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)、乳酸脱水素酵素 (LDH)、クレアチンキナーゼ、尿素、C 反応性タンパク質 (CRP)、トロポニン I、プロカルシトニン、D ダイマーなどがある。

しかしながら、これらのリスク因子は一般的に入院時にすでに重症であった患者に関連しており、入院後の医療ケアにもかかわらず発生する病態悪化とは異なる。さらに、COVID-19 患者における重症化や死亡のリスク因子を調査した研究のほとんどは、日本人以外の集団を対象としている。日本人患者に特有の COVID-19 アウトカムに関するデータは、いくつかの報告に限られている [3, 4]。

3 研究の目的および意義

本研究の目的は、日本感染症学会 (JAID) の COVID レジストリデータを用いて、日本人 COVID-19 入院患者において、入院後の医療ケアにもかかわらず重症化に至るリスク因子を同定することである。

3.1 リサーチクエスチョン

武漢株が優勢であった期間において、ワクチン未接種の日本人 COVID-19 入院患者において、入院時には重症ではなかったが入院後に重症化した患者の特徴およびリスク因子は何か。

3.2 社会的・学術的意義

本研究で同定されるリスク因子は、治療にもかかわらず悪化のリスクが高い患者の早期リスク層別化の重要性を示すものであり、将来の呼吸器パンデミックに対する準備戦略に資する知見を提供する。また、日本人集団特有の COVID-19 アウトカムに関するエビデンスの蓄積に貢献する。

4 研究対象者の選定方針

4.1 セッティング

日本感染症学会（JAID）の COVID レジストリに参加する日本全国 36 施設において、2020 年 1 月から 2021 年 3 月までの 15 ヶ月間に COVID-19 と診断され入院治療を受けた患者を対象とする。

4.2 適格基準

4.3 選択基準

- 核酸増幅検査（PCR 法または LAMP 法）あるいは免疫クロマトグラフィー法により COVID-19 の確定診断を受けた日本人患者
- 15 ヶ月間の研究期間中に入院治療を完了し、退院、転院、または死亡した患者

設定根拠：COVID-19 の確定診断を受けた患者を対象とすることで、診断の確実性を担保する。入院治療を完了した患者を対象とすることで、入院中の臨床経過を完全に把握できる。

4.4 除外基準

- 研究目的での医療情報の提供を拒否した患者
- 入院前にすでに重症であった患者
- 入院時にすでに重症であった患者

設定根拠：本研究は入院後の医療ケアにもかかわらず重症化するリスク因子を同定することを目的としているため、入院前または入院時にすでに重症であった患者は解析対象から除外する。これにより、入院時には重症でなかったが治療にもかかわらず悪化した患者の予測因子を特定できる。

4.5 予定研究対象者数およびその設定根拠

予定研究対象者数: 約 2,000 名 (modified full analysis set: mFAS)

本研究は探索的研究であり、先行研究に基づくサンプルサイズ計算ではなく、実行可能性に基づいて設定した。研究期間中に登録可能な患者数として約 2,000 名を見込んだ。国立感染症研究所の感染症発生動向調査および積極的疫学調査のデータによると、ICU 入室率 11%、侵襲的人工呼吸器使用率 14%、死亡率 2%、ECMO 使用 18 例であり、重症化率は 10～15% と保守的に推定された。2,000 名が登録された場合、約 200～300 例の重症 COVID-19 患者が含まれると予想され、多変量解析に十分なイベント数が確保できる。

5 研究の方法および研究の科学的合理性の根拠

5.1 デザイン

観察研究

[A: データ取得の向き]

- 後ろ向き（研究計画作成までに既に存在する試料・情報を取得する。当該研究とは異なる目的で研究対象者から直接取得された試料・情報の利用を含む）

[B2: 縦断的研究]

- コホート研究（多施設後ろ向きコホート研究）

本研究は、既存のレジストリデータを用いた後ろ向き多施設コホート研究である。入院時の患者背景、臨床症状、検査所見と入院後の重症化との関連を検討する。

6 方法

6.1 研究対象者の登録方法

本研究では、日本感染症学会（JAID）の COVID レジストリに登録された既存の診療情報を利用する。

6.1.1 データの取得経緯

全国 36 施設の研究協力担当者が、電子症例報告書（eCRF）を用いて患者の人口統計データおよび治療データを収集した。一部の施設では、国立国際医療研究センターが管理する COVID-19 REGISTRY JAPAN (COVIREGI-JP) のデータを許可を得て利用した。ベースラインデータには、患者背景、入院時の COVID-19 初発症状、および検査所見が含まれる。

6.1.2 ベースラインの定義

- COVID-19 で新規入院した患者：入院日に収集されたデータ（入院日のデータが利用できない場合は、重症化前の入院直後のデータ）
- 院内感染で COVID-19 に罹患した患者：COVID-19 発症前の直近のデータ

6.1.3 収集する独立変数

年齢、性別、BMI、妊娠の有無、入院時の身体所見（体温、循環動態、呼吸状態、GCS または JCS による意識レベル）、検査所見、喫煙歴、併存疾患（心血管疾患、呼吸器疾患、腎疾患、アレルギー疾患、免疫不全症（HIV や原発性免疫不全症を含む）、膠原病、悪性腫瘍、化学療法、放射線療法、基礎疾患に対する薬物療法など）。

6.1.4 アウトカムの定義

重症化は以下のいずれかと定義する：

- 気管挿管
- 人工呼吸器装着
- 体外式膜型人工肺（ECMO）使用
- 血液浄化療法の開始
- 集中治療室（ICU）入室
- 死亡

症例報告書は2021年4月1日から12月31日の間に登録された。すべてのデータは匿名化されている。

7 観察・検査・調査・報告項目とスケジュール

7.1 測定項目、測定方法、測定者または測定機関

本研究では、JAID-COVID レジストリに既に登録されている以下の項目を利用する。各参加施設の研究協力担当者が電子症例報告書（eCRF）を用いてデータを収集・登録している。

7.1.1 患者背景

年齢、性別、BMI、妊娠の有無、喫煙歴、入院理由（COVID-19による初回入院、COVID-19による転院、院内感染など）

7.1.2 発症時・入院時の症状

発熱、咳嗽、倦怠感、嗅覚障害、味覚障害、呼吸困難、意識障害、下痢

7.1.3 入院時身体所見

体温、経皮的動脈血酸素飽和度（SpO₂）、意識レベル（GCS、JCS）

7.1.4 入院時検査所見

- 血算：白血球数（WBC）、好中球、好酸球、単球、リンパ球、赤血球数（RBC）、ヘモグロビン（Hb）、ヘマトクリット（Ht）、平均赤血球容積（MCV）、血小板数（Plt）
- 生化学：総蛋白（TP）、アルブミン（ALB）、AST、ALT、ALP、 γ -GTP、LDH、BUN、クレアチニン（Cr）、eGFR
- 炎症マーカー：CRP、プロカルシトニン、フェリチン
- 凝固系：PT-INR、APTT、FDP、D-dimer、フィブリノゲン
- 糖代謝：HbA_{1c}

7.1.5 併存疾患

糖尿病、高血圧、脂質異常症、腎不全、透析、アレルギー疾患、膠原病、心弁膜症、うっ血性心不全、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺アスペルギルス症、悪性腫瘍（治癒・活動性）

7.1.6 アウトカム

重症化の有無（気管挿管、人工呼吸器、ECMO、血液浄化療法、ICU 入室、死亡）、入院時期、COVID-19 関連合併症、罹病期間

7.2 研究対象者の測定スケジュール

本研究は後ろ向き研究であり、研究計画作成以前に日常診療の中で収集された既存のデータを利用する。新たな検査や調査は実施しない。

表 2 データ収集項目一覧

カテゴリ	収集項目
患者背景	年齢、性別、BMI、妊娠、喫煙歴
発症時症状	発熱、咳嗽、呼吸困難、嗅覚・味覚障害など
入院時所見	体温、SpO ₂ 、意識レベル
検査所見	血算、生化学、炎症マーカー、凝固系
併存疾患	糖尿病、高血圧、悪性腫瘍など
治療内容	ステロイド、抗ウイルス薬、酸素療法など
アウトカム	重症化、死亡、入院期間

8 解析の概要

8.1 主要評価項目

入院後の重症化（気管挿管、人工呼吸器装着、ECMO 使用、血液浄化療法開始、ICU 入室、または死亡）の有無

8.2 副次的評価項目

- ・ 院内死亡率
- ・ 発症から入院までの期間
- ・ 入院期間
- ・ COVID-19 関連合併症の発生率

8.3 主な解析方法

8.3.1 解析対象集団

- Full analysis set (FAS)：除外基準適用後の全登録患者
- Modified full analysis set (mFAS)：入院日または入院前にすでに重症化していた患者を除外した集団。mFAS を主要解析対象とする。

8.3.2 統計解析

1. **単変量解析**：各説明変数について、重症化の有無に対するオッズ比（OR）および 95% 信頼区間（CI）を単変量ロジスティック回帰モデルにより算出する。連続変数は偏差値として標準化する。
2. **相関分析**：血小板/リンパ球比（PLR）、好中球/リンパ球比（NLR）と検査所見との関連を Spearman の相関係数を用いて評価し、相関行列図を作成する。
3. **多変量解析**：重症化リスクとの関連を評価するため、2 つの多変量ロジスティック回帰モデルを構築する。
 - モデル I：入院時に測定可能な客観的指標（検査データ等）に基づくリスク推定モデル
 - モデル II：検査データが利用できない場合の、入院時の問診および紹介医からの情報に基づくリスク推定モデル
4. **変数選択**：単変量解析で p 値 < 0.1 かつ欠損率 $< 30\%$ の変数、および臨床的に重要と考えられる変数をモデルに含める。
5. **欠損データの取り扱い**：多重代入法を用いて欠損データを補完する。
6. **モデル評価**：受信者動作特性（ROC）曲線下面積（AUC）を算出し、各モデルの判別能を評価する。
7. **有意水準**： $p < 0.05$ を統計学的に有意とする。

9 研究期間

1. 対象データの取得期間：2020 年 1 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日（15 ヶ月間）
2. データ解析期間：研究機関の長の実施許可日から 2029 年 3 月 31 日
3. 研究実施期間：研究機関の長の実施許可日から 2029 年 3 月 31 日

本研究は後ろ向き研究であり、研究対象者の登録・観察期間は研究計画作成以前に終了している。研究実施期間には、データ解析および論文作成・公表の期間を含む。

10 インフォームド・コンセント (IC) を受ける手順

10.1 既存情報を利用する場合の IC 手続き

本研究は、侵襲を伴わず、介入を行わない観察研究であり、既存の診療情報のみを利用する。研究対象者から新たに試料・情報を取得することはない。

研究に利用する情報は要配慮個人情報（診療情報）を含むが、以下の理由により適切な同意を得ることが困難であるため、情報公開文書による通知と拒否の機会の保障により実施する。

- 対象データの取得期間が 2020 年 1 月から 2021 年 3 月であり、研究計画作成時点で相当の期間が経過している
- 研究対象者が多数（約 2,000 名以上）であり、個別に同意を取得するための費用・時間が極めて膨大である
- 一部の研究対象者は既に死亡している可能性がある

10.2 情報公開の方法

各参加施設のホームページ上に情報公開文書を掲載し、研究の実施について広く周知する。情報公開文書には以下の内容を含める。

- 研究の名称、目的、意義
- 研究機関の名称および研究責任者の氏名
- 利用する情報の項目
- 研究対象者となる方の条件
- 情報の利用方法および管理方法
- 研究への参加を拒否する方法および連絡先

10.3 拒否の機会の保障

研究対象者またはその代理人が、自身の情報が本研究に利用されることを望まない場合は、研究課題ごとの相談窓口に連絡することで、いつでもデータの利用を停止することができる。拒否の意思表示があった場合、当該研究対象者のデータは解析対象から除外する。なお、拒否の意思表示をしたことにより、研究対象者が不利益を受けることはない。

10.4 研究計画書を変更した際の対応

研究計画書に変更が生じた場合は、倫理審査委員会の承認を得た上で、情報公開文書を更新する。研究対象者に新たな負担やリスクが生じる変更がある場合は、改めて適切な IC 手続きを検討する。

11 個人情報等の取り扱い

11.1 研究で取り扱う試料・情報等の個人情報等の種類

本研究で取り扱う情報は、氏名を研究用 ID に置き換えた情報であり、機関内で容易に個人に帰することができるため、**個人情報**に該当する。また、診療情報（病歴、検査結果、治療内容等）を含むため、**要配慮個人情報**に該当する。

11.2 個人情報等の作成の時期と方法

各参加施設において、研究協力担当者が以下の方法で個人情報を処理する。

1. 対象患者の診療録から必要な情報を抽出する
2. 氏名、患者 ID を施設固有の研究用 ID に置き換える（連結可能匿名化）
3. 対応表は各施設で厳重に管理し、データセンターには提供しない
4. 研究用 ID で匿名化されたデータのみをデータセンターに送付する

11.3 保有または利用する個人情報等の項目と安全管理措置

11.3.1 利用する個人情報等の項目

患者背景（年齢、性別、BMI 等）、発症時・入院時症状、入院時身体所見、入院時検査所見、併存疾患、治療内容、転帰情報

11.3.2 安全管理措置

- データを保存する電子媒体（HDD、サーバー等）は、施錠可能な部屋または保管庫に保管する
- データへのアクセスは、研究に関与する者のみに限定し、アクセス権限を適切に管理する
- ネットワーク経由でのデータ送受信時は、暗号化通信を使用する
- 外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールおよびウイルス対策ソフトを導入する
- 情報漏洩防止のため、研究者に対して個人情報保護に関する教育を実施する

11.4 研究組織全体の情報管理の責任を負う者

- 氏名: 研究メンバー（マスク済み） 所属: 所属機関名（マスク済み） 職位: 職位（マスク済み）

11.5 同意撤回（研究参加拒否）後のデータの取り扱いについて

研究対象者から研究参加拒否の意思表示があった場合、以下のとおり対応する。

1. 解析開始前：当該研究対象者のデータは解析対象から除外し、データセンターから削除する

2. 解析開始後・論文公表前：可能な限りデータを除外する。ただし、既に解析に組み込まれている場合は、個人が特定されない形でデータが使用されている旨を説明する
3. 論文公表後：既に公表された結果からの削除は困難であるが、今後の解析からは除外する

12 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスクおよび利益・総合的評価・対策

12.1 負担・リスク

本研究は既存の診療情報のみを利用する後ろ向き観察研究であり、研究対象者に対して新たな検査、治療、来院等を求めることはない。したがって、**身体的な負担・リスクはない**。

個人情報の取り扱いに関するリスクとして、情報漏洩により研究対象者のプライバシーが侵害される可能性がある。

12.2 利益

本研究への参加により、研究対象者個人が直接的な利益を得ることはない。

ただし、本研究の成果は、COVID-19 および将来の呼吸器感染症パンデミックにおける重症化リスクの高い患者の早期同定と治療戦略の改善に貢献する可能性があり、社会全体への潜在的な利益が期待される。

12.3 負担・リスクと利益の総合的評価

本研究は既存情報のみを利用するため、研究対象者への身体的負担・リスクはない。情報漏洩のリスクは適切な安全管理措置により最小化される。研究対象者個人への直接的利益はないが、本研究の社会的・学術的意義を考慮すると、リスクと利益のバランスは妥当であると考ええる。

12.4 負担・リスクを最小化する対策

- ・ 連結可能匿名化により、データセンターでは個人を特定できない形でデータを管理する
- ・ 対応表は各参加施設で厳重に管理し、研究目的以外での使用を禁止する
- ・ データへのアクセス権限を研究関係者に限定する
- ・ 研究成果の公表時は、個人が特定されない形で統計的に処理されたデータのみを使用する
- ・ 研究者に対して個人情報保護に関する教育を実施する

13 試料・情報の保管および廃棄の方法

13.1 試料・情報等の保管期間

「京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程第7条第2項の研究データの保存、開示等について定める件」第6項に従い、研究成果の最終公表後10年間保管する。

13.2 試料・情報等の保管方法

- 電子データは、アクセス制限が設定されたサーバーまたは暗号化された記憶媒体に保管する
- 記憶媒体は、施錠可能な部屋または保管庫に保管する
- 対応表（研究用IDと患者情報の対応）は、データとは別に各参加施設で厳重に管理する
- 定期的にバックアップを作成し、データの消失を防止する
- 研究関係者以外によるアクセスを防止するため、パスワード管理を徹底する

13.3 保管期間後に廃棄する場合はその処理の方法

保管期間終了後、以下の方法で廃棄する。

- 電子データ：データ消去ソフトウェアを用いて完全に消去、または記憶媒体を物理的に破壊する
- 紙媒体（対応表等）：シュレッダーにて裁断、または溶解処理により廃棄する
- 廃棄の記録を作成し、研究責任者が確認する

13.4 試料・情報の提供に関する記録の作成と管理

本研究は多機関共同研究であり、各参加施設からデータセンターへの情報提供を行う。情報の提供に関する記録を以下のとおり作成・管理する。

- 記録の作成: 情報を提供する際および提供を受ける際には、以下の事項を記録する。
 - － 提供先（または提供元）の研究機関名
 - － 提供した（または提供を受けた）情報の項目
 - － 提供年月日
 - － 提供の方法（電子媒体、暗号化通信等）
- 記録の保管: 当該記録は、研究データの保管期間と同一の期間（論文公表後10年間）、適切に保管する。

14 試料・情報の二次利用および他研究機関への提供の可能性

有

本研究で収集した情報は、将来の感染症研究のために二次利用する可能性がある。二次利用および他研究機関へ提供する際は、以下の手続きを経て実施する。

1. 新たな研究計画について、倫理審査委員会の承認を得る
2. 各参加施設のホームページ上で、研究の目的を含む研究実施の情報を公開する
3. 研究対象者が拒否できる機会を保障する

将来の研究について、研究対象者は研究課題ごとの相談窓口に連絡することで、情報の利用状況を確認し、利用の停止を申し出ることができる。

15 倫理審査委員会及び研究機関の長への報告内容および方法

本研究は侵襲を伴わない観察研究であるため、以下のとおり報告を行う。

- 研究の科学的合理性を損なう事実もしくは情報、または損なうおそれのある情報を得た場合は、速やかに安全性情報を提出する
- 研究の倫理的妥当性や研究実施の適正性、研究結果の信頼性を損なう事実もしくは情報、または損なうおそれのある情報を得た場合は、速やかに不適合報告書を提出する
- 年次報告は3年に1回以上行う
- 研究終了時には終了報告書を提出する

16 研究の資金・利益相反

16.1 研究資金の種類および提供者

本研究は、日本感染症学会（JAID）とアステラス製薬株式会社との共同研究資金により実施される。

16.2 提供者と研究者との関係

アステラス製薬株式会社は研究資金を提供するが、研究の企画、データ収集・管理、統計解析の実施、および論文執筆への直接的関与はない。研究の科学的独立性は研究者により担保される。

16.3 利益相反

利益相反について、京都大学利益相反ポリシー、京都大学利益相反マネジメント規程に従い、京都大学臨床研究利益相反審査委員会において適切に審査している。

17 研究対象者等およびその関係者からの相談等への対応

17.1 研究課題ごとの相談窓口

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み） 電話：000-000-0000

17.2 京都大学の苦情等の相談窓口

1. 研究対象者が京大病院の患者の場合、京大病院の教職員が行う研究の場合:

- 京都大学医学部附属病院 臨床研究相談窓口
- Tel: 075-751-4748
- E-mail: ctsodan@kuhp.kyoto-u.ac.jp

2. 京大病院が関与しない医学研究科の研究の場合:

- 京都大学医学研究科 総務企画課 研究推進掛
- Tel: 075-753-9301
- E-mail: 060kensui@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

3. 遺伝カウンセリングに関する窓口:

- 京都大学医学部附属病院 遺伝子診療部
- Tel: 075-751-4350 (受付時間 平日 13:00～16:30)

18 研究対象者等の経済的負担または謝礼

18.1 研究参加への謝礼

本研究は既存の診療情報のみを利用する後ろ向き研究であり、研究対象者に対して新たな負担を求めることはない。したがって、謝礼の支払いは行わない。

18.2 研究目的で行う検査・薬剤等の費用負担

本研究では、研究目的で新たな検査や薬剤投与を行うことはないため、研究対象者に追加の費用負担は生じない。

19 研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む）等の取扱い

19.1 研究結果等の説明方針

本研究では、既存の診療情報のみを用いた後ろ向き解析を行うため、新たに研究対象者個人の健康等に関する重要な知見が得られる可能性はない。

本研究の結果は集団としての統計解析結果であり、個々の研究対象者の診断や治療に直接影響を与えるものではない。したがって、研究結果を個別の研究対象者に説明することは行わない。

研究成果は学会発表や論文として公表し、社会に還元する。

20 研究の実施体制

各研究者の氏名、所属、職位、役割分担 (研究の総括、企画立案、運営、解析、論文執筆など) を記載すること。

20.1 研究責任者

- 氏名: 研究メンバー (マスク済み) 所属: 所属機関名 (マスク済み) 職位: 職位 (マスク済み) 役割: 役割の説明 (マスク済み)

20.2 分担研究者

分担研究者 1

役割の説明 (マスク済み)

所属機関名 (マスク済み) 職位 (マスク済み) 研究メンバー (マスク済み)

分担研究者 2

役割の説明 (マスク済み)

所属機関名 (マスク済み) 職位 (マスク済み) 研究メンバー (マスク済み)

分担研究者 3

役割の説明 (マスク済み)

所属機関名 (マスク済み) 職位 (マスク済み) 研究メンバー (マスク済み)

分担研究者 4

役割の説明 (マスク済み)

所属機関名 (マスク済み) 職位 (マスク済み) 研究メンバー (マスク済み)

分担研究者 5

役割の説明 (マスク済み)

所属機関名 (マスク済み) 職位 (マスク済み) 研究メンバー (マスク済み)

20.3 共同研究機関

日本感染症学会 (JAID) COVID レジストリに参加する全国 36 施設が共同研究機関として本研究に参加する。各施設の施設責任者は JAID-COVID レジストリの登録情報による。

主な参加施設:

- 東京医科大学病院 感染制御部

- 和歌山県立医科大学 感染制御部
- 虎の門病院 感染症科
- 国立病院機構京都医療センター 外科
- その他 32 施設

20.4 既存試料・情報の提供のみを行う施設

該当なし。すべての参加施設は共同研究機関として研究に参加する。

20.5 研究協力機関

該当なし。

20.6 研究場所の提供機関（研究協力施設）

該当なし。

20.7 試料・情報の管理について責任を有する者

- 氏名: 研究メンバー（マスク済み）所属: 所属機関名（マスク済み）職位: 職位（マスク済み）

20.8 統計解析担当者

- 氏名: 研究メンバー（マスク済み）所属: 所属機関名（マスク済み）職位: 職位（マスク済み）

20.9 データマネジメント担当者

- 氏名: 研究メンバー（マスク済み）所属: 所属機関名（マスク済み）職位: 職位（マスク済み）

20.10 研究事務局

所属機関名（マスク済み）職位（マスク済み）研究メンバー（マスク済み）

〒 000-0000 住所（マスク済み）電話：000-000-0000

21 研究実施計画書の変更、および改訂

研究実施計画書に変更及び改訂を要する場合は、再度、倫理審査委員会に変更申請を行い、承認を得るものとする。

22 遵守すべき倫理指針、倫理審査

本研究は「ヘルシンキ宣言」と「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づき実施する。

本研究は、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院 医の倫理委員会の審査を受け、研究機関の長の許可を得て実施する。

23 研究成果の帰属

本研究の成果は、京都大学に属するものとする。ただし、日本感染症学会（JAID）COVID レジストリデータの知的財産権については、JAID との合意に基づき管理される。

24 参考文献

- [1] Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with covid-19 in wuhan, china: a retrospective cohort study. *Lancet*, Vol. 395, No. 10229, pp. 1054–1062, 2020.
- [2] Elizabeth J Williamson, Alex J Walker, Krishnan Bhaskaran, et al. Factors associated with covid-19-related death using opensafely. *Nature*, Vol. 584, No. 7821, pp. 430–436, 2020.
- [3] Mari Terada, Hiroshi Ohtsu, Sho Saito, Kayoko Hayakawa, Shinya Tsuzuki, Yusuke Asai, et al. Risk factors for severity on admission and the disease progression during hospitalisation in a large cohort of patients with covid-19 in japan. *BMJ Open*, Vol. 11, No. 6, p. e047007, 2021.
- [4] Nobuaki Matsunaga, Kayoko Hayakawa, Mari Terada, Hiroshi Ohtsu, Yusuke Asai, Shinya Tsuzuki, et al. Clinical epidemiology of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 (covid-19) in japan: report of the covid-19 registry japan. *Clin Infect Dis*, Vol. 73, No. 11, pp. e3677–e3689, 2021.